

**Консультація по наданому МРТ головного мозку з в\в контрастуванням від
13.01.2023****П.І.Б. Жерліцина Анастасія Станіславівна****Дата народження:** 25.04.1976**Дата обстеження:** 13.01.2023**Дата консультації:** 17.01.2023**№ PMDA1068**

З анамнеза – лейоміосаркома матки T2NxM1. Стан після 4-х циклів ХТ по протоколу Гемцитабін+Доцетаксел+Авастин з прогресією в печінці (консультаційний висновок онколога від 4.01.2023р).

На серії МР-томограм головного мозку в тім'яно-скронево-потиличних областях кортикально-субкортикально візуалізуються без чітких контурів зони гіперінтенсивного МР-сигналу на T2WI та T2blade dark-fl, на більшому проміжку без ознак обмеження дифузії, однак, з включеннями гіпоінтенсивного МР-сигналу на SWI діаметром до 3-3,5мм (можуть свідчити за невеликі геморагічні осередки); після в\в контрастування визначається неінтенсивне накопичення контрастного препарату по «гіральному» типу. Аналогічні без чітких контурів осередки на нативних та постконтрастних зображеннях визначаються в корі лобних та тім'яних областей. За ходом субарахноїдальних просторів в лобних областях простежуються ділянки гіпоінтенсивного МР-сигналу на SWI, підвищеного на T2WI та DWI, з окремими локусами контрастування (можливо, ознаки локального САК чи геморагічного просякнення). Всі виявлені зміни не визначалися на МРТ від 20.09.2022р.

Серединні структури без латерального зміщення. Бічні шлуночки мозку симетричні, в розмірах не змінені, IV шлуночок розміщений по середній лінії. Розмежування сірої та білої речовини чітке.

Перивентрикулярні зони лейкоареозу шириною до 2мм.

Мозолисте тіло, базальні ганглії, мезенцефальні структури, структури задньої черепної ями, стовбур мозку ділянок патологічної зміни МР-сигналу не містять.

Краніовертебральний перехід: мигдалики мозочка без ознак пролабування у великий потиличний отвір.

Турецьке сидло: розташоване типово, звичайної конфігурації. Стінки рівні, контури гладкі, чіткі. Лійка гіпофіза розташована чітко по центру. Гіпофіз бобоподібної форми, верхній край симетричний.

Хіазма, зорові нерви без особливостей.

Пневматизація приносових пазух не порушена.

Висновок. Виявлена МР-картина патологічних змін в головному мозку, враховуючи дані анамнеза, локалізацію та МР-характеристики може з більшою вірогідністю відповідати posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES); слід диференціювати з проявами церебрального васкуліту.

Доцільні клініко-томографічне співставлення, МР-контроль в динаміці.

Лікар

к. мед. н. Скорохода Анна Орестівна